LA PHOTOTHERAPIE DANS LE TRAITEMENT DE L' ICTERE NEONATAL DANS LE SERVICE DE PEDIATRIE DU CHU-T

Nom du présentateur : DAO Lassina

Auteurs et coauteurs : **Auteurs et coauteurs** : DAO L, TRAORE O L, DJIGIMDE A.A, GOUETA O, BOUGOUMA R, DEMBELE E.

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- **Ictère:**
  - Coloration jaunâtre (téguments +muqueuses)
  - **Néonatal**: 0-28 jours (BT=70µmol/L)
- **Photothérapie**

But= Bilirubine non hydrosoluble Bilirubine hydrosoluble

- **Besoin en photothérapie ,**OMS 2016 :
- **14,1 millions NN** en besoin, **6 millions** non satisfait

Objectif

Objectif général

Faire un état des lieux de l'utilisation de la photothérapie dans le traitement de l'ictère néonatal dans le service de pédiatrie

Objectifs spécifiques

- ✓ Déterminer les aspects épidémiologiques de l'ictère
- ✓ Décrire les aspects diagnostiques des nouveau-nés ictériques traités par photothérapie
- ✓ Analyser les aspects pratiques de la photothérapie dans la prise en charge de l'ictère néonatal chez les nouveau-nés hospitalisés
- ✓ Identifier les modalités évolutives des nouveau-nés ictériques sous photothérapie
- ✓ Identifier les facteurs associés à l'évolution des nouveau-nés ictériques sous photothérapie.

Matériel et méthode(s)

- **Cadre de l'étude**: Service de pédiatrie du CHU-T
- **Type d'étude**: Transversale, descriptive et analytique
- **Période d'étude**: 05 Novembre 2024 au 19 Février 2025
- **Population d'étude**: Nouveau-né hospitalisé dans le service de pédiatrie du CHU-T
- **Echantillonnage** **Exhaustif**
- **Critères d'inclusion:** Nouveau-né ictérique ayant bénéficié de photothérapie

Matériel et méthode(s)

❑Technique de collecte de données

- Questionnaire anonyme
- Renseignements disponibles ;
- carnets de santé mère-enfant
- Dossiers médicaux
- Registres d'hospitalisation

Matériel et méthode(s)

❑ Analyse des données

- Micro-ordinateur 7.2.5.0 — WORD 2016® et EPI-INFO®
- Graphiques — Excel 2016
- Analyse multivariée bivariée — p<0,5 en analyse

Résultats

Fréquence

- ✓ Ictère néonatal 48,40%
- ✓ Photothérapie 87,91%
  - ✓ Âge moyen NN 2.4 jours ± 3.6
  - ✓ Sexe Masculin = 66,25%
- ✓ Âge moyen mère 26,82 ± 6 ans
- ✓ Accouchement Césarienne 40% V basse 60%
- ✓ A terme 52,5% Prématurés 47,5%

Résultats

- **Motif d'admission**
  - Détresse respiratoire 45%
  - Ictère : 22,5%
  - Prématurité : 20%
- **Caractéristiques de l'ictère**
  - ✓ Précoce : 35%
  - ✓ Franc : 81,25%

Résultats

Signes cliniques associés

- Fièvre : 20%
- Hypotonie : 53,75%
- Réflexes archaïques émoussés : 58,75%
- Pâleur : 43,75%

Taux de bilirubine avant la photothérapie

- ✓ Bilirubine totale moyenne : 191,3µmol/l ± 67,0
- ✓ Bilirubine libre moyenne : 189,1µmol/l +/- 65,9

Résultats

❑ Aspects pratiques de la photothérapie

- ❑ ❖ Photothérapie conventionnelle 100%
- ❖ Nombre de séances par jour
  - ✓ 03 séances 46,25%
  - ✓ 02 séances 42,5%
- ❖ Nombre d'heures par séance
  - ✓ 03 heures 96,25%

Résultats

Mode de sortie

- ❖ Amendement de l'ictère : 88,75%
- ❖ Taux de mortalité : 3,75%

Nombre total de séance reçues

- ❖ Nombre moyen 9,86 ± 5,05
- ❖ [10-15] 33,75%
- ❖ [5-10] 32,5%

❑ **Facteur associé à la durée de la photothérapie: prématurité P=0,007 (OR=7,4)**

Conclusion

- Ictère symptôme fréquent en période néonatal
- Evolution favorable sous photothérapie
- Nécessité de disponibiliser les appareils de photothérapie

Merci pour votre attention